



Sangrado en Hemofilia

Paso 1 Establecer gravedad de sangrado

S E V E R O	Sangrado SNC y ocular		
	Hemartrosis cadera		Hemartrosis
	Sangrado intraabdominal	Hematoma muscular extremidades	
	Sangrado con riesgo en vía aérea	Gastrointestinal	
	Sangrado que requiere transfusión	Heridas abiertas	
	Sangrado prolongado	Fracturas no quirúrgicas	
	Sangrado en iliopsoas	Hematuria persistente (2 - 3 días)	
	Lesiones por accidentes graves		
Objetivo: Llevar Factor deficitario a 100 UI/dl (100%)		Objetivo: Llevar Factor deficitario a 50-60 UI/dl (50-60%)	

M
O
D
E
R
A
D
O

Paso 2 Clasificar tipo y severidad de hemofilia

Hemofilia A: Déficit factor VIII	Leve: Factor basal VIII o IX 5-40% (5-40 UI/dl)
Hemofilia B: Déficit factor IX	Moderada: Factor basal VIII o IX 1-5% (1-5 UI/dl)
	Severa: Factor basal VIII o IX <1% (0%) (<1 UI/dl)
Si disponible, solicitar F VIII o IX preterapia, pero no retrasar el tratamiento	
* Si no lo conoce considerar hemofilia severa	

Paso 3 ¿Paciente con antecedente de inhibidor?

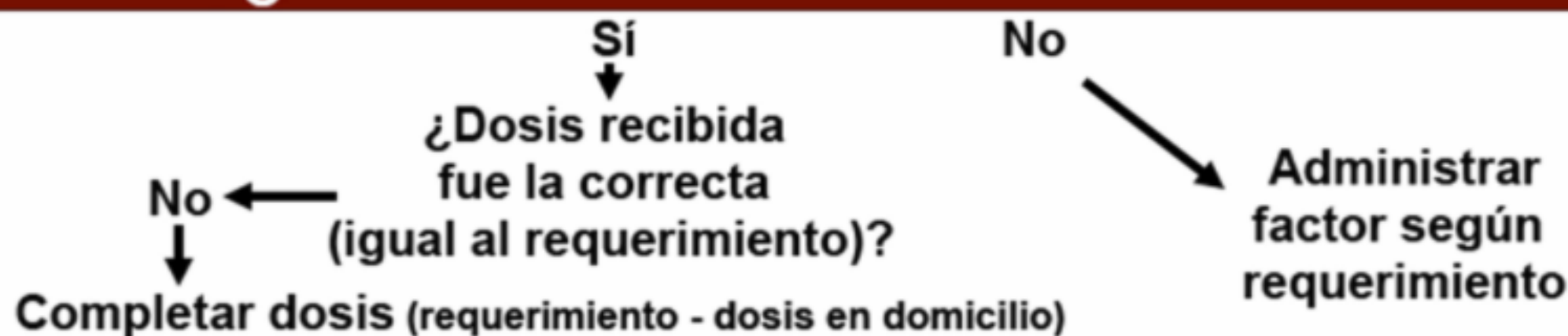
No

Sí → Usar pauta de paciente o consultar a hematología

Paso 4 Calcule requerimiento de factor

Hemofilia A FVIII	Por c/ 1 UI/kg que se administra, el factor aumenta 2 UI/dl en plasma Requerimiento (UI) = Peso (Kg) x (Objetivo - basal) / 2
Hemofilia B FIX	Por c/ 1 UI/kg que se administra, el factor aumenta 1 UI/dl en plasma Requerimiento (UI) = Peso x (Objetivo - basal)

Paso 5 ¿Paciente recibió factor en domicilio?



Liofilizado F VIII	Velocidad infusión	Liofilizado F IX
Frascos de 500 - 1000 UI	2-3 ml/min	Frascos de 250-500-1000 UI
Reconstituir concentrado y disolvente		Reconstituir concentrado y disolvente

